

Οδηγίες έναρξης Αντιπηκτικής Θεραπευτικής αγωγής στη Φλεβική Θρομβοεμβολική Νόσο (ΦΘΝ) – [Οδηγία ΕΟΦ]

	Αντιθρομβωτικά φάρμακα	Δόση	Έναρξη και Διάρκεια
Τεκμηριωμένη ΕΒΦΘ ή ΠΕ ή ΕΒΦΘ & ΠΕ	Enoxaparine (Clexane)	• Anti-Xa 100 IU/kg ΒΣ/12h. Σε ασθενείς με ΕΒΦΘ χωρίς συμπτώματα ΠΕ μπορεί να χορηγηθεί δόση Anti-Xa 150 IU/kg ΒΣ, άπαξ ημερησίως.	Σε ασθενείς με υψηλή πιθανότητα ΦΘΕ συνιστάται η άμεση έναρξη της αντιπηκτικής αγωγής με LMWH ή Fondaparinux σε θεραπευτικές δόσεις και τη διατήρηση αυτής της αγωγής κατά την περίοδο αναμονής των κλινικοεργαστηριακών κι απεικονιστικών αποτελεσμάτων του διαγνωστικού ελέγχου. Αν ο έλεγχος αποβεί αρνητικός για την ύπαρξη ΦΘΕ, η αντιπηκτική αγωγή διακόπτεται άμεσα. Σε ασθενείς με αντικειμενικά τεκμηριωμένη Φλεβική Θρομβοεμβολική Νόσο (ΕΒΦΘ ή/και ΠΕ) ή αντιπηκτική αγωγή ξεκινά άμεσα με τη χορήγηση LMWH ή Fondaparinux και ανταγωνιστών της βιταμίνης Κ. Η θεραπεία συνεχίζεται για περίπου 10 ημέρες, μέχρι το INR να σταθεροποιηθεί σε θεραπευτικά επίπεδα (INR: 2-3). Σε ασθενείς με ενεργή νεοπλασματική νόσο που παρουσιάζουν ΕΒΦΘ ή/και ΠΕ συστήνεται η χορήγηση LMWH σε θεραπευτικές δόσεις για διάστημα 6 μηνών.
	Tinzaparine (Innohep)	• Anti-Xa 175 IU/kg ΒΣ, άπαξ ημερησίως	
	Bemiparine (Ivor)	• Anti-Xa 115 IU/kg ΒΣ, άπαξ ημερησίως	
	Nadroparin (Fraxiparine)	• Anti-Xa 171 IU/kg ΒΣ, (sc), άπαξ ημερησίως ή • Anti-Xa 85 IU/kg ΒΣ, (sc), 2 φορές ημερησίως	
	Dalteparin (Fragmin)	• Anti-Xa 100 IU/kg ΒΣ, (sc), 2 φορές ημερησίως	
	Fondaparinux (Arixtra)	• Anti-Xa 7,5 mg (sc), άπαξ ημερησίως	
	Κλασική Ηπαρίνη (UFH) (βαριά ΠΕ)	• 400-800 IU/kg ΒΣ, ημερησίως, αργά ενδοφλεβίως με συσκευή συνεχούς έγχυσης. Η δόση της UFH πρέπει να προσαρμόζεται, ώστε η ηπαριναιμία στο πλάσμα να είναι 0,3-0,6 IU/ml.	
	Ανταγωνιστής της βιταμίνης Κ (Κουμαρινικά) (Sintrom)	✓ Σε ασθενείς με τεκμηριωμένη ΕΒΦΘ ή/και ΠΕ συστήνουμε την έναρξη χορήγησης ανταγωνιστών της vit. Κ την ίδια ημέρα με την έναρξη χορήγησης LMWH ή Fondaparinux ή UFH ✓ Η θεραπεία με LMWH ή Fondaparinux ή UFH πρέπει να συνεχίζεται παράλληλα με τη χορήγηση ανταγωνιστών της vit. Κ τουλάχιστον για 5 ημέρες και μέχρι να μετρηθεί το INR > 2 σε δύο συνεχείς μετρήσεις. ✓ Στη δευτερογενή πρόληψη της ΦΘΕ συνιστάται θεραπεία με ανταγωνιστές της vit. Κ σε δόσεις που εξασφαλίζουν τιμές INR μεταξύ 2-3. ✓ Η διάρκεια της θεραπείας είναι 3-6 μήνες. Σε ορισμένους ασθενείς με υψηλό κίνδυνο υποτροπής, η θεραπεία με ανταγωνιστές της βιταμίνης Κ μπορεί να είναι μακροχρόνια.	